

เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต

CQI | กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังใจ, ทักษะการฟื้นคืน (Resilience)

ที่มาและความสำคัญ

บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (PICU) ซึ่งเผชิญความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล และปัญหาด้านสังคมจากภาวะเจ็บป่วยของบุตร จึงพัฒนากิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” เพื่อส่งเสริมทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และ ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2569 รวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 48 คน

ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.75 (4.69 คะแนน จาก 5 คะแนน) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ข้อมูลเชิงคุณภาพสะท้อนการนำทักษะ Resilience ไปประยุกต์ใช้ เช่น การฝึกหายใจ การดูแลตนเอง การออกกำลังกาย และการกอดตัวเองเพื่อฟื้นคืนพลังใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และการมี “ทีมชีวิต” และมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคมเพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนในการดำเนินชีวิต

เป้าหมาย

- เสริมความรู้และทักษะการฟื้นคืนแก่ผู้ปกครอง
- ให้ผู้ปกครองรู้จักแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคม
- ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

กระบวนการพัฒนา (CQI)

ขั้นตอน	การดำเนินงาน
01  วิเคราะห์และพัฒนางานที่ควรทำ	วิเคราะห์ปัญหาผู้ปกครองในภาวะวิกฤต ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา/อบรมด้าน Resilience
02  ออกแบบชุดกิจกรรม	พัฒนา “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต” โดยแต่ละครั้งเลือกกิจกรรม 2 หมวด สลับหมุนเวียนตามความเหมาะสม
03  เตรียมกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่	คัดเลือกผู้ปกครองในบ้านพักพิง ปรุสถาน Child Friendly Hospital และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
04  ดำเนินกิจกรรม	45 นาที/ครั้ง วันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน ณ บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
05  ประเมินและสรุปผล	ประเมินและสรุปผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินกิจกรรม

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครอง ณ บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
- ใช้เวลา 45 นาที/ครั้ง
- ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2569

ชุดกิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจในภาวะวิกฤต”

แต่ละครั้งเลือกดำเนินกิจกรรม 2 หมวด สลับหมุนเวียนตามความเหมาะสม

1

Tune in : การกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

Grounding 5-4-3-2-1

5 สิ่งที่เห็น 4 สิ่งที่สัมผัสได้
3 สิ่งที่ได้ยิน 2 สิ่งที่ได้กลิ่น
1 สิ่งที่ได้ลิ้มรส



2

การฟื้นคืนทางอารมณ์และร่างกาย

- ฝึกการหายใจ 3 ท่า
- B.N.E. : Breath it – Name it – Embrace it
- สัมผัสที่ให้กำลังใจ ท่ากอด 3 รูปแบบ

สัมผัสที่ให้กำลังใจ



ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ที่ปรึกษา: นางสาวธารณีย์ ไชยมูล สส.ม. หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวกรนิภา คงหนองลาน สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
- นางสาวสุภาวดี บุญรอด สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์
- นางสาวมณีนิตา บัวสุวรรณ สส.บ. นักสังคมสงเคราะห์

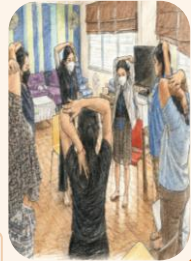
โทร. 3327 | E-mail: swgsnich@gmail.com

การฟื้นคืนทางกาย

3

- สังเกตสัญญาณจากร่างกาย
- ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ผัก 5 ท่ามีเนื้ข
- ทำสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกดี
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- แลกเปลี่ยนวิธีออกกำลังกายและการดูแลตนเอง

ดูแลคนที่เรารัก พร้อมกับไม่ลืมดูแลตัวเอง



4

การฟื้นคืนทางความคิด

- สำรวจความคิดกับเหตุการณ์
- ค้นหาจุดแข็งและสิ่งที่ทำได้ดี
- จัดการความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์
- เสริมความเชื่อมั่นในตนเอง



5

การฟื้นคืนทางสังคม : “ทีมชีวิต”

- สำรวจคนและแหล่งช่วยเหลือรอบตัว เช่น ครอบครัว/คนใกล้ชิด เพื่อน บุคลากรทางการแพทย์
- สิทธิ สวัสดิการและแหล่งเครือข่ายทางสังคม



ผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรม

8 ครั้ง

ผู้เข้าร่วม

48 คน

ความพึงพอใจเฉลี่ย

93.75%

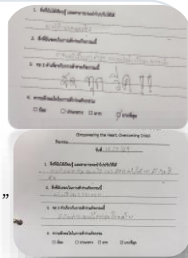
100%

พึงพอใจระดับ “มาก-มากที่สุด”



ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

“การกำหนดลมหายใจเข้าออกทำให้มีสมาธิ”
“ต้องดูแลตัวเองเพื่อคนที่เรารัก”
“รู้สึกดีและทำให้ร่างกายผ่อนคลายดี”
“ทำให้ออกกำลังกายทำให้เราสบายใจสบายกายได้”
“สุขสดชื่น”
“ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ช่วยให้ออกกำลังกาย ลดความเครียด”
“ได้ออกกำลังกายจะได้ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น”



การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการฟื้นคืน (Resilience) และแหล่งเครือข่ายสวัสดิการสังคม	ผู้เข้าร่วมได้รับกิจกรรมเสริมทักษะด้าน Resilience และ การเข้าถึงเครือข่ายสวัสดิการสังคม	1. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำตอบปลายเปิดผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางการนำทักษะ Resilience ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกกำหนดลมหายใจ การดูแลตนเอง การฟื้นคืนพลังใจ และการออกกำลังกาย
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีการจัดกิจกรรมตามแผน และมีแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม	2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายทราบแหล่งเครือข่ายสวัสดิการทางสังคม
		3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

บทเรียนและการพัฒนาต่อ

ความท้าทาย มีผู้เข้าร่วมเพิ่มระหว่างกิจกรรม ทำให้การรับเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง

การปรับปรุง สรุปประเด็นสำคัญเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมใหม่ติดตามได้

ระยะต่อไป พัฒนาสื่อ/QR Code และปรับรอบกิจกรรมให้เหมาะกับผู้เข้าร่วม

รายการอ้างอิง: Zdzun-Ryżewska, A., et al. (2021). Int J Environ Res Public Health, 18, 12019. Boonchoduang, N., et al. (2025). BMJ Paediatr Open, 9, e003669. Alzawad, Z., et al. (2021). Intensive Crit Care Nurs, 67, 103109. Canga, M., et al. (2020). J Educ Health Promot, 9, 9. Luo, Y., et al. (2022). Front Pediatr, 10, 871435.